Introduction aux domaines de la psychologie

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Objet

La psychologie étudie les comportements et les processus mentaux. Elle utilise plusieurs approches et ne se limite pas aux troubles psychiques.

Cognition

Attention, perception, mémoire, raisonnement et apprentissage éclairent la façon dont une information est sélectionnée, comprise et retenue.

Développement

Le développement concerne toute la vie. Les dimensions corporelles, cognitives, affectives et sociales interagissent avec le contexte.

Dimension sociale

Autrui et les groupes influencent les pensées et les conduites. Une explication individuelle seule peut manquer le rôle du contexte.

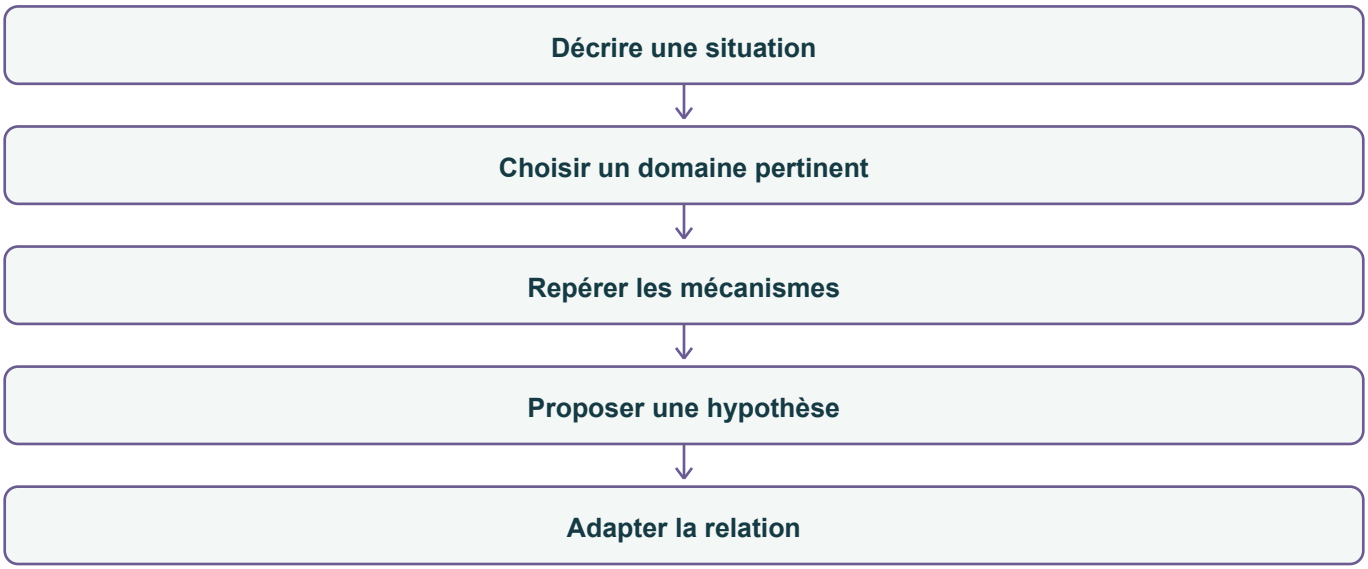
Santé

Les représentations, émotions, ressources et relations influencent l’expérience de santé, la prévention et l’adaptation à la maladie.

Application

En soins, décrire les faits avant de les interpréter. Une théorie aide à formuler des questions ; elle ne justifie pas une étiquette définitive sur la personne.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

La psychologie se limite-t-elle à la maladie mentale ? Non.

Une théorie suffit-elle à conclure sur une personne ? Non.

Pourquoi croiser les domaines ? Pour examiner plusieurs dimensions de la situation.

Sources et portée

UE B2 DOC 1 INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE.pdf

Rattachement au thème établi à partir des documents transmis ; ressource exacte ou capsule non vérifiée.

UE B.2

INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE

C'est quoi ?

La psychologie est la **science qui étudie les comportements humains et les processus mentaux**. Contrairement à la psychiatrie qui traite les troubles mentaux, la psychologie s'intéresse d'abord au **fonctionnement normal** de la personne.

Pour comprendre le champ, voici les **9 mots-clés à maîtriser** :

Psychologie : science des comportements et processus mentaux (perception, mémoire, émotions). S'intéresse aux individus **sans forcément de pathologie**.

Psychiatrie : branche **médicale** qui diagnostique et traite les troubles mentaux (dépression, schizophrénie, troubles bipolaires). Le psychiatre est médecin et peut prescrire.

Psychologue : professionnel diplômé à l'université (Master 2 minimum). Accompagne par la parole, réalise tests et évaluations. **N'est pas médecin, ne prescrit pas**.

Neuropsychologie : étudie les liens entre cerveau et comportement (troubles cognitifs après AVC, démences, TC).

Psychopathologie : étude des troubles mentaux et comportements anormaux (compréhension, mécanismes).

Psychanalyse : approche fondée par **Sigmund Freud** (fin XIXe siècle). Explore l'inconscient par la parole libre en séance.

Psychothérapie : traitement des troubles par la relation thérapeutique et la parole (plusieurs courants possibles).

Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC) : approches **structurées et brèves** qui modifient les pensées automatiques et les comportements problématiques.

Psychosomatique : étude du lien corps/esprit. Explique par exemple comment le stress chronique peut déclencher un ulcère.

Petite histoire de la psychologie

Origines philosophiques (Antiquité) Platon et Aristote (384–322 av. J.-C.) posent les bases : Aristote décrit une âme rationnelle et une âme sensitive, préfigurant le dualisme corps/esprit.

Vers l'autonomie scientifique (XIXe siècle) La psychologie se sépare de la philosophie et devient expérimentale.

- **Wilhelm Wundt (1832–1920)** : fonde le **premier laboratoire de psychologie scientifique** à Leipzig en 1879. Considéré comme le père de la psychologie moderne.
- **Hermann Ebbinghaus (1850–1909)** : premières recherches expérimentales sur la mémoire (courbe de l'oubli).

Le XXe siècle et ses grands courants

- **William James (1842–1910)** : publie *The Principles of Psychology* (1890), acte de naissance de la psychologie américaine.
- **Alfred Binet (1857–1911)** : conçoit le **premier test d'intelligence** (1905), ancêtre du QI.
- **Sigmund Freud** : fonde la psychanalyse et le concept d'inconscient.
- **John B. Watson et B. F. Skinner** : développent le **béhaviorisme** (le comportement se conditionne).
- **Aaron Beck** : formalise les TCC dans les années 1960.

Concepts philosophiques persistants

- **Dualisme corps/esprit** (Descartes) : deux entités distinctes qui interagissent
- **Rationalisme** : la connaissance vient de la raison
- **Empirisme** : la connaissance vient de l'expérience sensorielle

Les 4 grands domaines de la psychologie

Domaine	Ce qu'il étudie	Exemple concret
Cognitive	Perception, mémoire, attention, raisonnement	Pourquoi un patient âgé oublie son traitement
Sociale	Influence du groupe sur l'individu	Effet du regard des autres sur l'observance
Clinique et analytique	Évaluation et accompagnement des troubles	Entretien avec un patient dépressif
Développement	Changements psychiques de la naissance à la mort	Angoisse de séparation chez l'enfant hospitalisé

Objectifs de la psychologie en soins infirmiers

L'**arrêté du 20 février 2026** (référentiel de formation IDE) intègre la psychologie dans l'UE B.2 avec **3 objectifs pédagogiques principaux** :

1. **Observer l'état d'une personne** et son évolution dans le temps
2. **Observer les comportements** relationnels et sociaux
3. **Recueillir des données** sur l'état psychologique du patient

En pratique, la psychologie permet à l'IDE de :

- Comprendre pourquoi un patient refuse un soin
- Repérer une souffrance psychique cachée derrière une plainte physique
- Adapter sa communication au profil du patient (anxieux, sidéré, en colère, déni)
- Choisir la bonne posture face à un patient en détresse

Quel est le rôle IDE ?

- **Observer** l'état mental à chaque contact : humeur, anxiété, cohérence du discours, contact visuel
- **Recueillir et transmettre** les données psychologiques dans le dossier de soins (transmissions ciblées)
- **Adapter la communication** : ton, vocabulaire, rythme, distance selon la personne
- **Repérer précocement** une souffrance psychique (idées noires, isolement, changement brutal de comportement)
- **Orienter** vers le psychologue, le psychiatre ou le CMP (Centre Médico-Psychologique) si besoin
- **Rester neutre et bienveillant** : la psychologie enseigne à observer sans juger ni interpréter à la place du patient

> *L'IDE n'annonce **jamais** un diagnostic psychiatrique. Le diagnostic est médical. L'IDE accompagne le patient **après** l'annonce médicale.*

Les 5 réflexes IDE

1. **Écouter avant de faire** : un patient anxieux a besoin d'être entendu avant qu'on lui pose la perfusion. 30 secondes d'écoute peuvent débloquer 15 minutes de soin
2. **Nommer les émotions observées** sans les interpréter : *« Vous semblez préoccupé »* est mieux que *« Vous êtes déprimé »*
3. **Distinguer psychologue et psychiatre** : ne pas dire *« Je vous envoie voir le psy »* sans préciser lequel
4. **Transmettre à l'écrit avec précision** : *« Refus de soin lié à angoisse anticipatoire, verbalise peur de la douleur »* plutôt que juste *« refus »*
5. **Prendre soin de toi** : sans supervision ni analyse de pratiques, le soin relationnel s'épuise. C'est un vrai risque de burn-out professionnel

Sources

- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier : UE B.2 Sciences humaines et sociales
- Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels IDE
- APA (American Psychological Association) : classification des courants psychologiques
- Wilhelm Wundt, *Principles of Physiological Psychology* (1874)
- William James, *The Principles of Psychology* (1890)
- Alfred Binet et Théodore Simon, *Échelle métrique de l'intelligence* (1905)
- HAS : recommandations sur le repérage de la souffrance psychique

Cours rédigé par Lily Bailly · **usemypatient.com** · reproduction et partage interdits

Exemplaire personnel de Laetitia Hélary · laetitiahlary@yahoo.fr